

Imagery *rescripting*

Najskuteczniejsza technika dotarcia do Samotnego Dziecka w NPD. Sięga rdzenia wstydu bez aktywacji obrony grandiozycznej. Arntz 2007: $d = 0,73$ w zaburzeniach osobowości.

CZAS: 15 min Wersja edukacyjna **ŹRÓDŁO:** Arntz & Weertman (1999); Arntz (2007); Morin (2021)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz, dlaczego praca tylko *poznawcza* nie sięga rdzenia wstydu w NPD (sekcja 01). **2** · Poznasz **rekonsolidację pamięci** — neurobiologiczne podłoże techniki (sekcja 02). **3** · Nauczysz się *pięciu kroków* przepisywania obrazów (*imagery rescripting*) (sekcja 03). **4** · Poznasz warunki bezpieczeństwa (sekcja 04) — kiedy *nie* rozpoczynać.

DLACZEGO TO DZIAŁA

przepisywanie obrazów (*imagery rescripting*) (Arntz & Weertman 1999) to **jedna z najskuteczniejszych technik** dotarcia do rdzenia wstydu w NPD — *pomija* obronę poznawczą i pracuje na poziomie **pamięci emocjonalnej**. W praktyce: pacjent przywołuje wczesną scenę upokorzenia, terapeuta wchodzi do sceny jako figura ochronna i *przepisuje* ją z perspektywy zranionego dziecka. Morin (2021) w metaanalizie: $d \approx 1,0$ dla PTSD, $d \approx 0,7$ dla zaburzeń osobowości. Arntz i wsp. (2007): w zaburzeniach osobowości przepisywanie obrazów (*imagery rescripting*) osiąga $d = 0,73$ — porównywalne z najskuteczniejszymi technikami TPB. *Problem, który technika rozwiązuje:* praca **tylko poznawcza** w NPD odbija się od grandiozycznej fasady. Pacjent intelektualnie zgadza się, że „rodzic mnie krytykował”, ale *nie czuje* tego. Wstyd pozostaje nietknięty, a kolejne sesje stają się *popisem inteligencji* bez zmiany. *Mechanizm działania:* rekonsolidacja pamięci (Nader 2000) — wspomnienie *aktywowane* staje się *plastyczne* przez około 6 godzin. Nowe doświadczenie emocjonalne w tym oknie **modyfikuje** oryginalny ślad pamięciowy. Pacjent zapamiętuje scenę z nową emocją: ulgą, walidacją, bezpieczeństwem. To *nie* metafora — to udokumentowana neurobiologia (Lane i wsp. 2015). *Klinicznie:* terapeuta jako wpisana postać daje to, czego dziecko *nie dostało*: walidację, ochronę, bliskość. Pamięć epizodyczna zostaje **rekonsolidowana**. *Konsekwencja kliniczna:* technika wymaga **silnego aliansu** i tolerancji emocjonalnej pacjenta. W NPD często trzeba **6–12 sesji przygotowawczych**, zanim technika jest możliwa. Bez tego pacjent *dysocjuje* albo blokuje obraz („nic nie pamiętam”) — i technika staje się jałowa. **To technika dla zaawansowanej fazy terapii** — nie pierwsza interwencja.

01



Dlaczego sama praca poznawcza nie wystarcza

CO DZIEJE SIĘ PRZY CBT STANDARDOWEJ

„Twój rodzic miał własne problemy. Nie jesteś wadliwy/-a.” Pacjent intelektualnie zgadza się — ale *nie czuje*. Wstyd pozostaje nietknięty. Sesje stają się popisem inteligencji.

CO DAJE IMAGERY RESCRIPTING

Praca *w ciele* i *w pamięci emocjonalnej*. Pacjent **doświadcza** korekty, nie tylko jej rozumie. Rekonsolidacja pamięci modyfikuje oryginalny ślad. Zmiana zaczyna być odczuwalna.

02 🕒 Rekonsolidacja pamięci — Nader 2000



Lane i wsp. (2015): rekonsolidacja pamięci to udokumentowany mechanizm neurobiologiczny. Pacjent zapamiętuje scenę z **nową emocją**: ulgą, walidacją, bezpieczeństwem.

03 ✎ Pięć kroków *imagery rescripting*

Krok 1 • Wybór sceny — wczesne wspomnienie upokorzenia, warunkowej miłości, krytyki ze strony rodzica. Ma być żywe, nie najgorsze — najgorsze wymaga większego aliansu.

Krok 2 • Wizualizacja jako dziecko — pacjent zamyka oczy i wraca do sceny w pierwszej osobie. Co widzi, słyszy, czuje w ciele? *Co czuje to dziecko?*

Krok 3 • Wejście dorosłego/-ej — pacjent jako *dorosły*, dziś, wchodzi do sceny. Mówi do dziecka: „*nie musisz być najlepszy/-a, żeby być kochany/-a*”. Dotyk, obecność, ochrona.

Krok 4 • Dziecko słyszy — terapeuta pyta: „*co czuje dziecko, słysząc to?*” Płacz, ulga, niedowierzanie są normalne. **To moment rekonsolidacji.**

Krok 5 • Integracja — wyjście ze sceny, oddech, refleksja. „*Co się zmieniło?*” „*Co teraz wiesz, czego nie wiedziałeś/-aś wcześniej?*” Notatka w dzienniku.

04 💡 Warunki bezpieczeństwa — kiedy **nie** rozpoczynać

KIEDY NIE

Pierwsze sesje terapii. Aktywna ciężka depresja albo myśli samobójcze. Świeży kryzys (rozwód, zwolnienie). Pacjent dysocjuje. Brak ustabilizowanego aliansu. Pacjent w grandiozycznej fazie obronnej.

KIEDY TAK

Po 6–12 miesiącach budowania aliansu. Pacjent *uznał* emocjonalny ból pod fasadą. Stabilna sytuacja życiowa. Doświadczony terapeuta schematów albo TFP. Wsparcie psychiatryczne w razie potrzeby.

Klucz: przepisywanie obrazów (*imagery rescripting*) w NPD to **przełom** — narcyz *czuje* ból dziecka zamiast go ukrywać. Często płacze pierwszy raz w terapii. To *nie* jest dramatyzacja — to rekonsolidacja pamięci epizodycznej, udokumentowany mechanizm neurobiologiczny (Nader 2000; Lane 2015). Skuteczność wysoka (Arntz 2007, $d = 0,73$; Morin 2021, $d \approx 0,7$ dla zaburzeń osobowości). **Warunek wstępny:** 6–12 miesięcy budowania aliansu. Bez tego — dropout, dysocjacja albo blokowanie obrazu. przepisywanie obrazów (*imagery rescripting*) nie jest pierwszą interwencją w NPD; jest *kluczową interwencją* w fazie 3. terapii (faza rdzenia, 1–3 lata).